

Signos de alarma y factores de riesgo (tabaco, alcohol, VPH)

1. Introducción y relevancia clínica

El **cáncer de cabeza y cuello** constituye un problema de salud pública de alta relevancia, dado su impacto funcional (habla, deglución, respiración) y social. En Chile, representa alrededor del **4–5% de los tumores malignos**, siendo el **carcinoma escamoso** el tipo histológico predominante.

Los sitios más afectados son la **cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, laringe y nasofaringe**.

La **detección temprana** de lesiones sospechosas en **Atención Primaria de Salud (APS)** permite diagnosticar el cáncer en etapas iniciales, donde la curación puede alcanzar hasta **90%**. Sin embargo, el retraso diagnóstico —por la similitud con procesos inflamatorios comunes y la falta de sospecha clínica— conduce a que **más del 60%** de los casos se detecten en **estadios avanzados (III–IV)**.

El conocimiento de los **factores de riesgo** y **signos de alarma** por parte del médico general o del profesional de APS es clave para la **pesquisa oportuna y derivación temprana** al especialista ORL o maxilofacial.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **carcinoma escamoso de cabeza y cuello (CECC)** surge de la transformación maligna del epitelio escamoso de las mucosas del tracto aerodigestivo superior.

La carcinogénesis es un proceso **multifactorial y multietápico**, influido por agentes **químicos, virales, genéticos y ambientales**, que inducen mutaciones y alteraciones epigenéticas.

2.1 Etapas fisiopatológicas de la carcinogénesis

1. **Iniciación:** daño genético primario (por agentes carcinógenos como el tabaco o el VPH).
2. **Promoción:** proliferación de clones celulares mutados (por inflamación crónica, alcohol, irritación mecánica).
3. **Progresión:** adquisición de autonomía proliferativa, invasión y capacidad metastásica.

2.2 Mecanismos moleculares

- **Mutaciones de TP53, EGFR, RAS, p16INK4a, PTEN.**
 - En infecciones por **VPH (subtipos 16 y 18)**:
 - Proteína **E6** degrada **p53**,
 - Proteína **E7** inactiva **pRb**,
 - Lo que favorece replicación descontrolada y resistencia a apoptosis.
 - En **fumadores crónicos**, el daño por carcinógenos del tabaco produce **displasia epitelial progresiva**, pasando por etapas de **leucoplasia, eritroplasia y carcinoma in situ**.
-

3. Clínica: signos, síntomas y diagnóstico diferencial

El cáncer de cabeza y cuello **no presenta síntomas específicos en etapas iniciales**. Sin embargo, existen **signos de alarma** que deben motivar **derivación inmediata a ORL o maxilofacial**.

3.1 Signos y síntomas de alarma (criterios clínicos de derivación)

Región afectada	Signos de alarma	Diagnóstico diferencial
Cavidad oral	Úlcera o lesión que no cicatriza >2–3 semanas , sangra fácilmente o es indurada; leucoplasia o eritroplasia persistente; dolor irradiado a oído ; movilidad dentaria sin causa .	Aftas, candidiasis, liquen plano erosivo, trauma protésico.
Orofaringe / amígdalas	Asimetría amigdalар, masa o úlcera persistente, odinofagia unilateral, trismo o disfagia progresiva.	Amigdalitis crónica, absceso periamigdalino.

Nasofaringe	Epistaxis recurrente unilateral, obstrucción nasal, hipoacusia conductiva unilateral, adenopatía cervical posterior.	Adenoiditis, sinusitis, poliposis nasal.
Laringe / hipofaringe	Disfonía >3 semanas, odinofagia irradiada a oído, tos seca persistente, disnea inspiratoria o estridor.	Laringitis crónica, nódulos vocales, RGE.
Cuello	Adenopatía dura, fija e indolora, especialmente supraclavicular o submandibular, sin foco infeccioso.	Adenitis reactiva, tuberculosis, linfoma.

□ En EUNACOM, el enunciado “disfonía >3 semanas en fumador” o “úlceras orales persistentes” debe siempre hacer sospechar **cáncer escamoso de cabeza y cuello**.

3.2 Diagnóstico diferencial global

- Procesos inflamatorios crónicos (amigdalitis, rinitis, laringitis).
- Lesiones benignas (nódulos, pólipos, papilomas).
- Granulomatosis (tuberculosis, sarcoidosis).
- Lesiones premalignas: **leucoplasia** (placa blanca), **eritroplasia** (placa roja, mayor riesgo maligno).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación inicial en APS

- **Inspección directa** de cavidad oral y orofaringe con buena iluminación.
- **Palpación cervical sistemática** (submandibular, yugular, supraclavicular).
- **Exploración con depresor lingual** buscando úlceras o masas.
- **Documentar lesiones sospechosas** y derivar con prioridad a ORL.

4.2 Exámenes diagnósticos en nivel especializado

Examen	Propósito
Nasofibroscofia / laringoscopia flexible	Permite visualización directa de mucosa nasal, orofaríngea y laríngea.
Biopsia incisional / excisional	Confirmación histológica (carcinoma escamoso).
TAC / RM de cabeza y cuello	Evaluar extensión tumoral y compromiso de tejidos blandos u óseos.
PAAF de adenopatías	Diagnóstico de metástasis cervical.
PET-CT (si disponible)	Búsqueda de metástasis a distancia o primario oculto.
Marcadores virales	VPH (p16, PCR) o EBV en nasofaringe.

5. Factores de riesgo principales (según evidencia MINSAL y OMS)

Tipo	Factores y ejemplos	Mecanismo
1. Conductuales	Tabaquismo (principal), alcohol (sinérgico), masticación de betel , mal higiene oral , uso de prótesis irritantes .	Irritación y exposición crónica a carcinógenos; alteración epitelial progresiva.
2. Infecciosos	Virus del Papiloma Humano (VPH 16,18) : orofaringe, amígdalas, base de	Inserción del ADN viral (E6/E7 o LMP1) →

	lengua. Virus de Epstein-Barr (VEB): nasofaringe.	inhibición de p53/Rb → proliferación celular.
3. Ambientales / laborales	Exposición a polvo de madera, formaldehído, níquel, asbesto, metales pesados.	Daño genético por inhalación crónica de irritantes.
4. Dietéticos / metabólicos	Dieta pobre en frutas y verduras; déficit de vitamina A y antioxidantes ; consumo de alimentos ahumados/nitrosaminas.	Aumento de especies reactivas de oxígeno y daño celular.
5. Genéticos / predisponentes	Síndrome de Fanconi, ataxia-telangiectasia, historia familiar de cáncer ORL.	Defectos en reparación del ADN.
6. Radiación / inmunosupresión	Radioterapia previa, trasplante, VIH.	Inestabilidad genómica e inmunidad disminuida.

6. Tratamiento (enfoque preventivo y manejo de factores de riesgo)

El objetivo en APS es **reducir la exposición a factores prevenibles y derivar lesiones sospechosas** precozmente.

6.1 Intervenciones preventivas

1. Suspensión del tabaco:

- Asesoramiento breve + farmacoterapia (bupropión, vareniclina, parches de nicotina).
- Reducción de riesgo de cáncer laríngeo >50% tras 10 años de abstinencia.

2. Reducción del consumo de alcohol:

- Intervención breve (modelo AUDIT-C), derivar a salud mental si abuso.
3. **Educación oral y dental:**
- Higiene bucal, control de prótesis y lesiones traumáticas.
4. **Vacunación contra VPH (MINSAL):**
- Niños y niñas 9–14 años → esquema de 2 dosis (0 y 6–12 meses).
 - Previene cánceres anogenitales y orofaríngeos asociados a VPH 16–18.
5. **Protección laboral:** uso de mascarillas, ventilación en carpinterías, metalurgia, soldadura.
6. **Promoción de dieta saludable:** frutas, verduras, antioxidantes, limitar carnes procesadas.

6.2 Manejo médico y derivación

- Toda **lesión oral o faringolaríngea persistente >2–3 semanas** → **derivar a ORL / Cirugía de cabeza y cuello** con prioridad.
 - **Biopsia** es obligatoria ante sospecha de **lesión premaligna** (leucoplasia, eritroplasia).
 - Pacientes con **antecedente de tabaco/alcohol** deben recibir **tamizaje ORL anual** (en APS o especialista).
-

7. Complicaciones y pronóstico

7.1 Si no se detectan precozmente:

- Diagnóstico tardío → requerirá **cirugías mutilantes** (laringectomía, glossectomía).
- Secuelas funcionales severas: **afonía, disfagia, traqueostomía permanente**.
- Metástasis ganglionares o pulmonares (hasta 50% en estadios IV).

7.2 Pronóstico global

- **Estadios iniciales (I–II):** supervivencia a 5 años >80%.
 - **Estadios avanzados (III–IV):** <40%.
 - **Cánceres asociados a VPH:** mejor respuesta a quimiorradioterapia (hasta 90% de curación).
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas clínicas

1. **Disfonía >3 semanas** → sospecha de **cáncer laríngeo**.
2. **Úlcera oral que no cicatriza o placa blanca/roja persistente** → **biopsia inmediata**.
3. **Epistaxis unilateral + hipoacusia conductiva + masa cervical** → **carcinoma nasofaríngeo**.
4. **Tabaco + alcohol** = riesgo **sinérgico** (multiplicador, no aditivo).
5. **VPH-16** → causa principal de cáncer orofaríngeo en **jóvenes no fumadores**.
6. **La vacunación contra VPH** es una **medida preventiva oncológica**.
7. **Adenopatía cervical dura e indolora** en adulto → cáncer de cabeza y cuello hasta demostrar lo contrario.

✗ Errores comunes

- Atribuir **disfonía crónica a reflujo o laringitis** sin estudio.
- Tratar **úlceras orales crónicas con antimicóticos o corticoides** sin biopsia.
- No **palpar el cuello** en examen ORL básico.
- No **registrar hábito tabáquico/alcohólico** en ficha clínica.
- Ignorar **lesiones premalignas (leucoplasia/eritroplasia)**.
- No considerar que **pacientes jóvenes con cáncer orofaríngeo pueden ser VPH positivos** (no fumadores).

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **cáncer de cabeza y cuello** es prevenible en gran medida; su diagnóstico precoz depende de **sospecha clínica activa en APS**.
2. **Factores de riesgo principales:** tabaco, alcohol, VPH (orofaringe), VEB (nasofaringe).
3. **Signos de alarma:** disfonía >3 semanas, úlcera oral persistente, epistaxis unilateral, adenopatía cervical indolora.
4. La **biopsia** es el examen confirmatorio; **toda lesión que no cicatriza >2–3 semanas debe derivarse a ORL**.
5. **Tabaco + alcohol** tienen efecto **sinérgico** en la carcinogénesis escamosa.
6. **Vacunación contra VPH y abandono del tabaco** son pilares preventivos en salud pública.
7. **Detección precoz salva funciones vitales y voz**, mejorando sobrevida y calidad de vida.